



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:36

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: AS 13001D1131 - EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

Fecha de Nacimiento: 05/04/1966

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO CHINO CALLE LAS FLORES

Teléfono: 3217743979

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO

OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: ESTÁ SOLO

Teléfono Acomp.:

Dirección Acomp.:

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Fecha de Atención: 21/01/2020 09:07

Admisión: AD568215

Edad: 53 año(s), 9 mes(es) 16 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.:

Especialidad: INFECTOLOGIA

Impreso por: Pinvestigacion

Sexo: M

Estado Civil: Soltero

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 02/01/2020 08:11

Cama: 4--11B

Motivo de la Consulta:

ME ESTOY AHOGANDO

ANTECEDENTES:

- PERSONALES:

* 1-> EPOC, LESION RENAL

* 2-> NEIGA

* 5-> NIEGA

* 6-> SALBUTAMOL, BROMURO

- FAMILIARES:

NIEGA

- ALÉRGICOS:

- QUIRÚRGICOS:

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE MASCULINO CON ANTECEDENTES DE EPOC EXACERBADO. LESION RENAL AGUDA PRE-RENAL QUIEN HACE VARIOS DIAS FUE DADO DE ALTA DE ESTA INSTITUCION DE SALUD, INGRESANDO EN EL DIA DE HOY POR SUS PROPIOS MEDIOS CON UN FAMILIAR POR PRESNETRA SENSACION D DIFICULTAD RESPIRATORIA, QUE NO MEJORA CON LOS INHALADORES, ADEMAS REFIERE FRAMILIAR QUE NO SE HACE EL TRATAMIENTO ADECUADAMENTE.

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O2 AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SIGNOS VITALES EN METAS, CON REPORTE DE PARACLINICOS CONTROL DENTRO DE PARAMETROS ADECUADOS, PACIENTE QUIEN CUMPLIO DE MANERA SATISFACTORIA TIEMPO PROTOCOLARIO CON TRATAMIENTO RIPE INTRAHOSPITALARIO HOY ULTIMO DIA (D14), QUIEN TIENE PENDIENTE 3ERADOSIS DE PENICILINA BENZATINICA (23-01-12) QUE SE PUEDE ADMINISTRAR DE MANERA AMBULATORIA POR LO QUE SE DECIDE DAR ALTE MEDICA CON TRATAMIENTO RIPE AMBULATORIO, ADEMAS CON CITA CONTROL CON INFECTOLOGIA, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Revisión Por Sistema:

RESPIRATORIO

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

EN REGULAR ESTADO GENERAL, Y MSUCULONUTRICIONAL, ALERTA, AFEBRIL, SO2 78% AMBIENTE

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, PUPILAS REACTIVAS, MUCOSA HUMEDAS, CUELLO MOVIL, SIN ADNEOPATIAS

Tórax:

RCCRS, NO SOPLOS, PULMONES CON TIRAJES SUBCOSTALES, RONCUS EN AMBAS BASES, Y DISMINUCION DE MURMULLO VESICULAR UNIOVERSAL

Abdomen:

BLANDO, DEPRESIBLE, N NO MASAS NI MEGALIAS, NO DOLOROSO

Piel y faneras:

PALIDEZ GENERALIZADA

Genito-Urinario:

NO EPXORADO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

Extremidades:

EUTÓRICAS, SIN EDEMA

Sistema nervioso central:

GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO CON ANTECEDENTES DE EPOC EXACERBADO. LESION RENAL AGUDA PRE-RENAL QUIEN HACE VARIOS DIAS FUE DADO DE ALTA DE ESTA INSTITUCION DE SALUD, INGRESANDO EN EL DIA DE HOY POR SUS PROPIOS MEDIOS CON UN FAMILIAR POR PRESNETRA SENSACION D DIFICULTAD RESPIRATORIA, QUE NO MEJORA CON LOS INHALADORES, ADEMAS REFIERE FRAMILIAR QUE NO SE HACE EL TRATAMIENTO ADECUADAMENTE. AL EXAMEN FISICO PULMONES CON TIRAJES SUBCOSTALES, RONCUS EN AMBAS BASES, Y DISMINUCION DE MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL CON DESATURACION Y EXACERBACION DE TOS POR LO QUE SE CONSIDERA EXACERBACION DE EPOC, SOLICITANDOSE PARA CLINICOS, CANULA NASAL, GASES ARTERIALES, RX DE TORAX Y VAL POR MED INTERNA. SE LE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIEN ENES NETIDEN Y ACEPTAN CONDUCTA

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:**Diagnóstico Principal:** J441 : ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA**Diagnóstico Relacionado 1:** Z519 : ATENCION MEDICA, NO ESPECIFICADA**EVOLUCIONES:**

Fecha: 03/01/2020: 09:38:16, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOHN ALEXANDER ANGULO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS CON IDX:

1. EPOC EXACERBADO ANTONHISEN TIPO 1

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE QUE PASO BUENA NOCHE. NIEGA TOS, DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULAR ESTADO GENERAL, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS , NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL HUMEDA, PIEL SIN LESIONES , CUELLO MÓML SIN MASAS NI ADENOMEGLIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PRESNETE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMEIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 57 AÑOS DE EDAD EN EL CONTEXTO DE EPOC EXACERBADO ANTONHISEN TIPO 1 SIN SIGNOS DE SOBREINFECCION. ACTUALMENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, SIGNOS VITALES DENTRO DE PARAMETROS NORMALES, SIN SIGNOS DE SIRS NI DIFICULTAD RESPIRATORIA PACIENTE QUIEN SE DECIDE HOSPITALIZAR, SE INICIA TERAPIA RESPIRATORIA Y SE DECIDE SOLICITAR TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO POR HALLAZGO DE MASA PULMONAR APICAL IZQUIERDA. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 03/01/2020: 09:39:00, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOHN ALEXANDER ANGULO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS CON IDX:

1. EPOC EXACERBADO ANTONHISEN TIPO 1

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE QUE PASO BUENA NOCHE. NIEGA TOS, DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULAR ESTADO GENERAL, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS , NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL HUMEDA, PIEL SIN LESIONES , CUELLO MÓML SIN MASAS NI ADENOMEGLIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PRESNETE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMEIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 57 AÑOS DE EDAD EN EL CONTEXTO DE EPOC EXACERBADO ANTONHISEN TIPO 1 SIN SIGNOS DE SOBREINFECCION. ACTUALMENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, SIGNOS VITALES DENTRO DE PARAMETROS NORMALES, SIN SIGNOS DE SIRS NI DIFICULTAD RESPIRATORIA PACIENTE QUIEN SE DECIDE HOSPITALIZAR, SE INICIA TERAPIA RESPIRATORIA Y SE DECIDE SOLICITAR TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO POR HALLAZGO DE MASA PULMONAR APICAL IZQUIERDA. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 05/01/2020: 12:29:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MARCO ANTONIO LUJAN AGAMEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE:

1. EPOC EXACERBADO ANTONHISEN TIPO 1

2. LESION RENAL AGUDA

3. TBC A DESCARTAR??

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE TOS SIN EXPECTORACION, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, NIEGA NAUSEAS, VOMITOS, U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULAR ESTADO GENERAL, CONSCIENTE ORIENTADO EN LA TRES ESFERAS , NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, PABELLONES AURICULARES BIEN IMPLANTADOS, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SIN ALTERACIONES, FOSAS NAALES PERMEABLES, CAVIDAD ORAL HUMEDA, PIEL SIN LESIONES , CUELLO MÓML SIN MASAS NI ADENOMEGLIAS, TÓRAX NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN CAMPO PULMONAR DERECHO, DISMINUIDO EN APICE IZQUIERDO, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS PERSISTENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO NO EXPLORADO, EXTREMEIDADES SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES, SISTEMA NERVIOSO SIN DETERIORO NEUROLÓGICO APARENTE. CON GLASGOW 15 / 15.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

SIGNOS VITALES: TA:110/80 MMHG FC: 83LPM FR:18 RPM SATO2: 96% TEMP: 36.8°C

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD EN EL CONTEXTO DE EPOC EXACERBADO ANTONHISEN TIPO 1 SIN SIGNOS DE SOBREINFECCION. ACTUALMENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, SIGNOS VITALES DENTRO DE PARAMETROS NORMALES, SIN SIGNOS DE SIRS NI DIFICULTAD RESPIRATORIA EL DIA DE HOY EN RONDA MEDICA SE SUSPENDE TERAPIA RESPIRATORIA A EXCEPCION DEL OXIGENO, SE SOLICITAN BACILOSCOPIAS SERIADAS, SE INDICA INICIAR TRATAMIENTO ANTIBIOTICO PARA GEREMENES COMUNES. PENDIENTE REALIZACION DE TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADA ADICIONALMENTE SE SOLICITA VALORACION POR INFECTOLOGIA DADO REPORTE DE RADIOGRAFIA DE TORAX DONDE SE EVIDENCIA MASA APICAL IZQUIERDA Y SECUELAS DE TBC. ATENTOS A EVOLUCION CLINICASE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 06/01/2020: 12:26:29, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MARCO ANTONIO LUJAN AGAMEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE:

1. MASA PULMONAR APICAL IZQUIERDA EN ESTUDIO??

2. TUBERCULOSIS PULMONAR

Subjetivo:

REFIERE CON PERSISTENCIA DE TOS Y DE EXPECTORACION, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA:110/60 mmHg FC: 72 LPM FR: 18 RPM SO2: 94% T°C: 36°C

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, NO FACIES ÁLGICA. NORMOCÉFALO. ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS. MUCOSA ORAL SEMIHÚMEDA, NO LESIONES. CUELLO SIN INGURGITACION YUGULAR, NO ADENOPATÍAS. RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS, NI RUIDOS AGREGADOS TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO DE FORMA GENERALIZADA, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN APICE IZQUIERDO, ABDOMEN SIN MEGALIAS, NO DOLOR A LA PALPACIÓN, NO ASCITIS, REFLUJO HEPATOYUGULAR NEGATIVO. EXTREMIIDADES SIMÉTRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. SNC: CONSCIENTE, ORIENTADO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.

Análisis:

PACIENTE QUIEN INGRESO CON SOSPECHA DE EPOC EXACERBADO, SIN EMBARGO EL DIA DE AYER POR ANTECEDENTE DE TBC E IMAGENES DE INGRESO SE SOLICITARON BACILOSCOPIAS, SE OBSERVA REPORTE DE PRIMERA BACILOSCOPIA POSITIVA +++, POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE PACIENTE DEBE CONTINUAR MANEJO POR PARTE DEL SERVICIO DE INFECTOLOGIA, TIENE PENDIENTE TAC DE TORAX PARA DEFINIR LESION DESCRITA EN TOMOGRAFIA. SE CIERRA MANEJO POR MEDICINA INTERNA, CONTINUA POR INFECTOLOGIA. SE SOLICITA PRUEBA DE VIH, SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 07/01/2020: 12:22:30, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. MASA PULMONAR APICAL IZQUIERDA EN ESTUDIO?? 2. TUBERCULOSIS PULMONAR

Subjetivo:

REFIERE CON PERSISTENCIA DE TOS Y DE EXPECTORACIÓN, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA:110/60 mmHg FC: 72 LPM FR: 18 RPM SO2: 94% T°C: 36°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, NO FACIES ÁLGICA. NORMOCÉFALO. ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS. MUCOSA ORAL SEMIHÚMEDA, NO LESIONES. CUELLO SIN INGURGITACION YUGULAR, NO ADENOPATÍAS. RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS, NI RUIDOS AGREGADOS TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO DE FORMA GENERALIZADA, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN APICE IZQUIERDO, ABDOMEN SIN MEGALIAS, NO DOLOR A LA PALPACIÓN, NO ASCITIS, REFLUJO HEPATOYUGULAR NEGATIVO. EXTREMIIDADES SIMÉTRICAS, EUTROFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. SNC: CONSCIENTE, ORIENTADO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. 06/01/2020 VIH: POSITIVO.

Análisis:

PACIENTE DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. MASA PULMONAR APICAL IZQUIERDA EN ESTUDIO?? 2. TUBERCULOSIS PULMONAR Y PRUEBA DE VIH POSITIVA Y BK POSITIVA +++. PACIENTE ACTUALMENTE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, AFEBRIL. SE SUSPENDEN ANTIBIOTICOS Y SE INICIA TERAPIA RIPE (RHZE) EL DIA DE HOY JUNTO CON PIRIDOXINA. ESTA PENDIENTE DOS MUESTRAS DE BACILOSCOPIA, Y LA REALIZACIÓN DE TAC DE TÓRAX SIMPLE Y CONTRASTADO. SE SOLICITA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA VIH, FUNCIÓN HEPÁTICA, FUNCIÓN RENAL, CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y PERFIL INFECCIOSO COMPLETO (VDRL, HBAgS, ANTICORE IgG e IgM HB, IgM HC, IgG E IgM PARA CMV, HERPES, EPSTEIN BARR Y TOXOPLASMA). SE CONTINUA DEMÁS ORDENES MEDICAS. SE DILIGENCIA FICHA DE NOTIFICACIÓN Y SE ADJUNTA A LA HISTORIA CLINICA. SE EXPLICA AL PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 08/01/2020: 10:24:23, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20. 3. SÍFILIS?4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Subjetivo:

REFIERE PERSISTENCIA DE TOS Y DE EXPECTORACIÓN, NIEGA FIEBRE, DISNEA, DOLOR U OTRAS SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSCIENTE, ISOCORIAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE TBC PULMONAR Y VIH DE NOVO, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O2 AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SE CONTINUA MANEJO ESTABLECIDO, PENDIENTE VIH CONFIRMATORIA Y CONTEO DE CD4 PARA DETERMINAR INICIO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3. TAC DE TÓRAX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA "Los campos pulmonares imagen de bulas subpleurales apicales derechas. Presencia de opacidades nodulares y alveolar en el ápice izquierdo y opacidad alveolar hacia la lingula con cavitación hacia el ápice izquierdo por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso". LO ANTERIOR COMPATIBLE CON DX DE TUBERCULOSIS PULMONAR. PENDIENTE CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + PERFIL INFECCIOSO. SE CONTINUA RESTO DE MANEJO ESTABLECIDO, SE EXPLICA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 09/01/2020: 10:01:32, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20. 3. SÍFILIS 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPONATREMIA LEVE, HIPOMAGNESEMA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE PERSISTENCIA DE TOS Y EXPECTORACIÓN. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE TBC PULMONAR E INFECCIÓN POR VIH DE NOVO, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. SE RECIBE REPORTE DE PARACLÍNICOS CON ANALÍTICA SANGUÍNEA QUE MUESTRA UNA ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA Y TROMBOCITOSIS, CON PRUEBAS DE FUNCIÓN RENAL NORMAL, IONOGRAMA CON EVIDENCIA DE HIPONATREMIA E HIPOMAGNESEMA LEVES, POR LO CUAL SE CONTINÚA REPOSICIÓN INTRAVENOSA DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL PARA MAÑANA ADEMÁS SE RECIBE REPORTE DE VDRL REACTIVO CON 4 DILS Y PRUEBA TREPONÉMICA (FTABS) POSITIVA, POR LO QUE SE DECIDE INICIAR MANEJO PARA SÍFILIS CON PENICILINA BENZATINICA. PACIENTE CONTINUA CON IGUAL MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO PREVIAMENTE. AÚN A LA ESPERA DE PRUEBA DE VIH CONFIRMATORIA Y CONTEO DE CD4 PARA DETERMINAR INICIO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 10/01/2020: 09:45:51, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20. 3. SÍFILIS 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPONATREMIA LEVE, HIPOMAGNESEMA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, ASINTOMÁTICO

Objetivo:

NOTA DE PROCEDIMIENTO

SE LE INFORMA AL PACIENTE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR, EL CUAL ENTENDIENDO, ACEPTA Y DA AUTORIZACIÓN PARA EL MISMO, PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE REALIZA INFILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL EN ÁREA A PUNCIÓN, POSTERIORMENTE SE PASA ESPINOCAT NÚMERO 18, SE AVANZA ATRAVERANDO LIGAMENTO AMARILLO, SE RETIRA MANDRIL Y SE OBTIENE RETORNO DE LCR, CLARO, NO SANGRE, SE MIDE PRESIÓN DE APERTURA LA CUAL INDICA 8 CC/H₂O, POSTERIORMENTE SE RECOLECTA 3 FRASCOS CADA UNO DE 30 GOTAS PARA ENVIAR A LABORATORIO, SE FINALIZA PROCESO DE RECOLECCIÓN, SE INTRODUCE NUEVAMENTE MANDRIL Y SE RETIRA ESPINOCAT, SE DEJA CUBIERTA EL ÁREA CON GASAS Y ESPARADRAPO, SE POSICIONA AL PACIENTE Y SE LE DAN RECOMENDACIONES.

Análisis:

PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES

Fecha: 10/01/2020: 09:46:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20. 3. SÍFILIS 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPONATREMIA LEVE, HIPOMAGNESEMA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, ASINTOMÁTICO

Objetivo:

NOTA DE PROCEDIMIENTO

SE LE INFORMA AL PACIENTE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR, EL CUAL ENTENDIENDO, ACEPTA Y DA AUTORIZACIÓN PARA EL MISMO, PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE REALIZA INFILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL EN ÁREA A PUNCIÓN, POSTERIORMENTE SE PASA ESPINOCAT NÚMERO 18, SE AVANZA ATRAVERANDO LIGAMENTO AMARILLO, SE RETIRA MANDRIL Y SE OBTIENE RETORNO DE LCR, CLARO, NO SANGRE, SE MIDE PRESIÓN DE APERTURA LA CUAL INDICA 8 CC/H₂O, POSTERIORMENTE SE RECOLECTA 3 FRASCOS CADA UNO DE 30 GOTAS PARA ENVIAR A LABORATORIO, SE FINALIZA PROCESO DE RECOLECCIÓN, SE INTRODUCE NUEVAMENTE MANDRIL Y SE RETIRA ESPINOCAT, SE DEJA CUBIERTA EL ÁREA CON GASAS Y ESPARADRAPO, SE POSICIONA AL PACIENTE Y SE LE DAN RECOMENDACIONES.

Análisis:

PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES

Fecha: 10/01/2020: 09:47:58, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20. 3. SÍFILIS 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPONATREMIA LEVE, HIPOMAGNESEMA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, ASINTOMÁTICO

Objetivo:

NOTA DE PROCEDIMIENTO

SE LE INFORMA AL PACIENTE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR, EL CUAL ENTENDIENDO, ACEPTA Y DA AUTORIZACIÓN PARA EL MISMO, PREVIA ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE REALIZA INFILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL EN ÁREA A PUNCIÓN, POSTERIORMENTE SE PASA ESPINOCAT NÚMERO 18, SE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

AVANZA A TRAVEZ A LIGAMENTO AMARILLO, SE RETIRA MANDRIL Y SE OBTIENE RETORNO DE LCR, CLARO, NO SANGRE, SE MIDE PRESIÓN DE APERTURA LA CUAL INDICA 8 CC/H2O, POSTERIORMENTE SE RECOLECTA 3 FRASCOS CADA UNO DE 30 GOTAS PARA ENVIAR A LABORATORIO, SE FINALIZA PROCESO DE RECOLECCIÓN, SE INTRODUCE NUEVAMENTE MANDRIL Y SE RETIRA ESPINOCAT, SE DEJA CUBIERTA EL AREA CON GASAS Y ESPARADRAPO, SE POSICIONA AL PACIENTE Y SE LE DAN RECOMENDACIONES.

Análisis:

PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES

Fecha: 10/01/2020: 11:06:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPONATREMIA LEVE, HIPOMAGNESEMIA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE PERSISTENCIA DE TOS Y EXPECTORACIÓN. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA.

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O2 AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CON EVIDENCIA DE HIPONATREMIA E HIPOMAGNESEMIA LEVE, POR LO CUAL SE CONTINÚA REPOSICIÓN INTRAVENOSA DE MAGNESIO Y SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL Y HEMOGRAMA, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12) DOSIS DE PENICILINA BENZATINA PENDIENTE INICIO DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE REALIZA PUNCIÓN LUMBAR, PENDIENTE RESULTADO DE PARACLÍNICOS EN LCR. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 11/01/2020: 11:54:24, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPONATREMIA LEVE, HIPOKALEMIA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE PERSISTENCIA DE TOS Y EXPECTORACIÓN. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA.

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS EN LCR: KOH, GRAM(-), BACILOSCOPIA ZIEHL NEELSEN Y TINTA CHINA: NEGATIVOS. VDRL: NO REACTIVO. ADA: 8.0. CITOQUÍMICO: LEUCOCITOS: 15, LINFOCITOS: 100%, GLUCOSA: 51, PROTEÍNAS: 60, LDH: 16. ACS CONTRA CRIPTOCOCO: NO DISPONIBLE.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O2 AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CON EVIDENCIA DE HIPONATREMIA E HIPOKALEMIA LEVE, POR LO CUAL SE CONTINÚA REPOSICIÓN INTRAVENOSA DE MAGNESIO Y SE INICIA ION K POR 24 HORAS. PASE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12) DOSIS DE PENICILINA BENZATINA PENDIENTE INICIO DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. PARACLÍNICOS EN LCR DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 12/01/2020: 11:12:51, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO: HIPOMAGNESEMIA LEVE, HIPOKALEMIA LEVE.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE PERSISTENCIA DE TOS Y EXPECTORACIÓN. NIEGA CEFALEA, NIEGA PICOS FEBRILES, NIEGA NAUSEAS, NIEGA VÓMITOS, NIEGA DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA.

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: TOXOPLASMA IGG: POSITIVO, IGM NEGATIVO; CITOMEGALOMRUS: IGG: POSITIVO, IGM NEGATIVO; PENDIENTE HERPES I Y II, EBV Y CULTIVO PARA MTB EN LCR Y ESPUTO, PENDIENTE BK #2Y#3 + GENEXPERT.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CON EVIDENCIA DE HIPOMAGNESEMA E HIPOKALEMIA LEVE, POR LO CUAL SE CONTINÚA REPOSICIÓN INTRAVENOSA DE MAGNESIO Y DE ION K POR 24 HORAS MÁS, SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12) DOSIS DE PENICILINA BENZATINA PENDIENTE INICIO DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 13/01/2020: 08:52:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA TOS, NIEGA EXPECTORACIÓN, NIEGA CEFALEA, FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSCIENTE, ISOCORIAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: TOXOPLASMA IGG: POSITIVO, IGM NEGATIVO; CITOMEGALOMRUS: IGG: POSITIVO, IGM NEGATIVO; PENDIENTE HERPES I Y II, EBV Y CULTIVO PARA MTB EN LCR Y ESPUTO, PENDIENTE BK #2Y#3 + GENEXPERT.

12/01 PARACLÍNICOS: CLORO 102, POTASIO 4.3, MG 1.8, SODIO 130.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL QUE EVIDENCIA MEJORA DE NIVELES DE POTASIO POR LO QUE SE SUSPENDE ION K Y PERSISTENCIA DE LEVE HIPOMAGNESEMA POR LO CUAL SE CONTINÚA REPOSICIÓN INTRAVENOSA DE MAGNESIO HASTA EL DÍA DE MAÑANA Y SE SOLICITA IONOGRAMA CONTROL, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12) DOSIS DE PENICILINA BENZATINA INICIO DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO, PACIENTE QUIEN REFIERE TOS NO PRODUCTIVA LO QUE DIFICULTA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE ESPUTO POR LO QUE EL DÍA DE HOY SE LE SOLICITA TERAPIA RESPIRATORIA PARA MOTIVAR EXPECTORACIÓN. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 14/01/2020: 08:36:05, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA TOS, NIEGA EXPECTORACIÓN, NIEGA CEFALEA, FIEBRE, VÓMITOS U OTRAS SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSCIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS: CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12) DOSIS DE PENICILINA BENZATINA INICIO DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 15/01/2020: 08:28:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA TOS, NIEGA EXPECTORACIÓN, NIEGA CEFALEA, FIEBRE, VÓMITOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

U OTRASINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA CORRESPONDIENTE A EL DÍA DE MAÑANA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12). CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 15/01/2020: 08:29:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCÍTICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA TOS, NIEGA EXPECTORACIÓN, NIEGA CEFALEA, FIEBRE, VÓMITOS U OTRASINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA CORRESPONDIENTE A EL DÍA DE MAÑANA (16-01-20) Y TERCERA (23-01-12). CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 16/01/2020: 08:30:05, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCÍTICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, DIARREA, VÓMITOS U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS:

13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA CORRESPONDIENTE A EL DÍA DE HOY Y TERCERA EL DÍA (23-01-12). CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 16/01/2020: 08:30:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCÍTICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, DIARREA, VÓMITOS U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS:

13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, PENDIENTE SEGUNDA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA CORRESPONDIENTE A EL DÍA DE HOY Y TERCERA EL DÍA (23-01-12). CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROMIAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 17/01/2020: 14:45:28, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCÍTICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, DIARREA, VÓMITOS U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARA CLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, A QUIEN SE LE APLICA SEGUNDA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA CORRESPONDIENTE DEL DÍA DE AYER Y PENDIENTE TERCERA EL DÍA (23-01-12). CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROMIAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO, EL DÍA DE HOY SE DECIDE SOLICITAR IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 17/01/2020: 14:46:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCÍTICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE (RESUELTA) 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, DIARREA, VÓMITOS U OTRA SINTOMATOLOGÍA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA. TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARA CLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, A QUIEN SE LE APLICA SEGUNDA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA CORRESPONDIENTE DEL DÍA DE AYER Y PENDIENTE TERCERA EL DÍA (23-01-12). CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROMIAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO, EL DÍA DE HOY SE DECIDE SOLICITAR IONOGRAMA Y FUNCIÓN RENAL CONTROL. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 18/01/2020: 11:23:14, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCÍTICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

PIEBRE, VOMITOS, DIARREA U OTRASINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9 18/01/2020 BUN 17, CREATININA 1.18, CLORO 97, POTASIO 4.56, MAGNESIO 1.6, SODIO 127.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, QUEIN TIENE PENDIENTE 3ERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA (23-01-12). SE RECIBE REPORTE DE IONOGRAMA CONTROL QUE EVIDENCIA HIPOMAGNESEMA, POR LO QUE SE INICIA REPOSICION DE MAGNESIO Y SE LE SOLICITA IONOGRAMA MAS MAGNESIO CONTROL ADEMÁS SE LE SOLICITA BUN Y CREATININA. CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 18/01/2020: 11:24:01, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA).

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGAN SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA FIEBRE, VOMITOS, DIARREA U OTRASINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9 18/01/2020 BUN 17, CREATININA 1.18, CLORO 97, POTASIO 4.56, MAGNESIO 1.6, SODIO 127.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, QUEIN TIENE PENDIENTE 3ERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA (23-01-12). SE RECIBE REPORTE DE IONOGRAMA CONTROL QUE EVIDENCIA HIPOMAGNESEMA, POR LO QUE SE INICIA REPOSICION DE MAGNESIO Y SE LE SOLICITA IONOGRAMA MAS MAGNESIO CONTROL ADEMÁS SE LE SOLICITA BUN Y CREATININA. CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 19/01/2020: 10:02:56, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JEAN CARLOS PINTO ANGARITA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA)

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGAN SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA FIEBRE, VOMITOS, DIARREA U OTRASINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9 18/01/2020 BUN 17, CREATININA 1.18, CLORO 97, POTASIO 4.56, MAGNESIO 1.6, SODIO 127. 18/01 BUN 18, CREA 1.20, CLORO 99, POTASIO 4.61, MG 1.5, SODIO 126.6

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. IONOGRAMA CONTROL DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, CONTINUA RESTO DE MANEJO MÉDICO ESTABLECIDO, QUEIN TIENE PENDIENTE 3ERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA (23-01-12). SE RECIBE REPORTE DE IONOGRAMA CONTROL QUE EVIDENCIA PERSISTENCIA HIPOMAGNESEMA, POR LO QUE SE CONTINUA REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE LE SOLICITA IONOGRAMA MAS MAGNESIO CONTROL ADEMÁS SE LE SOLICITA BUN Y CREATININA. CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL Y CUMPLIENDO PROTOCOLO DE TERAPIA RIPE HOY SU DIA 12. PENDIENTE BACILOSCOPIA #2 Y #3 + CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

Fecha: 20/01/2020: 07:51:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO 6.1 HIPOMAGNESEMA LEVE 6.2 HIPOKALEMIA (RESUELTA)

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGAN SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS, DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9 18/01/2020 BUN 17, CREATININA 1.18, CLORO 97, POTASIO 4.56, MAGNESIO 1.6, SODIO 127. 18/01 BUN 18, CREA 1.20, CLORO 99, POTASIO 4.61, MG 1.5, SODIO 126.6 19/01/2020 BUN 16, CREATININA 0.92, CLORO 103, POTASIO 4.7, MAGNESIO 1.5, SODIO 129.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SIGNOS VITALES EN METAS, CUMPLIENDO TIEMPO PROTOCOLARIO CON TRATAMIENTO RIPE INTRAHOSPITALARIO HOY DÍA 13, QUIEN TIENE PENDIENTE 3ERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA (23-01-12). SE RECIBE REPORTE DE IONOGRAMA CONTROL QUE EVIDENCIA PERSEVERANCIA HIPOMAGNESEMA LEVE, POR LO QUE SE CONTINUA REPOSICIÓN DE MAGNESIO Y SE LE SOLICITA IONOGRAMA MAS MAGNESIO, SE EVIDENCIA TAMBIEN AZOADOS EN DESCENSO POR LO QUE SE SOLICITA FUNCIÓN RENAL CONTROL. CONTINUA EN TERAPIA ANTIRETROVIRAL Y MISMO MANEJO MEDICO INSTAURADO, PENDIENTE CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS + RESTO DE PERFIL INFECCIOSO. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 21/01/2020: 09:02:52, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO (RESUELTO)

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGAN SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS, DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9 18/01/2020 BUN 17, CREATININA 1.18, CLORO 97, POTASIO 4.56, MAGNESIO 1.6, SODIO 127. 18/01 BUN 18, CREA 1.20, CLORO 99, POTASIO 4.61, MG 1.5, SODIO 126.6 19/01/2020 BUN 16, CREATININA 0.92, CLORO 103, POTASIO 4.7, MAGNESIO 1.5, SODIO 129. 20/01/2020 BUN 9, CLORO 100, POTASIO 5, MAGNESIO 1.6, SODIO 128, CREAT 0.72.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SIGNOS VITALES EN METAS, CON REPORTE DE PARACLINicos CONTROL DENTRO DE PARAMETROS ADECUADOS, PACIENTE QUIEN CUMPLIO DE MANERA SATISFACTORIA TIEMPO PROTOCOLARIO CON TRATAMIENTO RIPE INTRAHOSPITALARIO HOY ULTIMO DÍA (D14), QUIEN TIENE PENDIENTE 3ERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA (23-01-12) QUE SE PUEDE ADMINISTRAR DE MANERA AMBULATORIA POR LO QUE SE DECIDE DAR ALTE MEDICA CON TRATAMIENTO RIPE AMBULATORIO, ADEMÁS CON CITA CONTROL CON INFECTOLOGIA, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 21/01/2020: 09:03:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR. 2. VIH DE NOVO DX 07-01-20 (CD4: 199). 3. SÍFILIS INDETERMINADA 4. CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 5. ANEMIA SEVERA NORMOCITICA NORMOCROMICA HETEROGÉNEA 6. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO (RESUELTO)

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGAN SÍNTOMAS URINARIOS, NIEGA FIEBRE, VÓMITOS, DIARREA U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE CONSIENTE, ISOCORIA NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, SIN SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, NI LESIONES EN CAVIDAD ORAL. CUELLO: MÓVIL, SIMÉTRICO, NO MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, NI DANZA CAROTÍDEA TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, CON PRESENCIA DE SIBILANCIAS Y RONCUS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO EN ÁPICE IZQUIERDO, SIN OTROS AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS. ABDOMEN: PLANO, PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA, SIN MASAS NI MEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS DISTALES PRESENTES, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, PACIENTE CON ATENCIÓN DISPERSA, POCO COMUNICATIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 13/01 CLORO 99, POTASIO 4.7, SODIO 128.0, MAGNESIO 1.9 18/01/2020 BUN 17, CREATININA 1.18, CLORO 97, POTASIO 4.56, MAGNESIO 1.6, SODIO 127. 18/01 BUN 18, CREA 1.20, CLORO 99, POTASIO 4.61, MG 1.5, SODIO 126.6 19/01/2020 BUN 16, CREATININA 0.92, CLORO 103, POTASIO 4.7, MAGNESIO 1.5, SODIO 129. 20/01/2020 BUN

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

9, CLORO 100, POTASIO 5, MAGNESIO 1.6, SODIO 128, CREAT 0.72.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DESCRITOS, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE, AFEBRIL, TOLERANDO O₂ AMBIENTE Y VÍA ORAL, SIN SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SIGNOS VITALES EN METAS, CON REPORTE DE PARACLÍNICOS CONTROL DENTRO DE PARÁMETROS ADECUADOS, PACIENTE QUIEN CUMPLIO DE MANERA SATISFACTORIA TIEMPO PROTOCOLARIO CON TRATAMIENTO RIPE INTRA INSTITUCIONAL HOY ÚLTIMO DÍA (D14), QUIEN TIENE PENDIENTE 3ERA DOSIS DE PENICILINA BENZATÍNICA (23-01-12) QUE SE PUEDE ADMINISTRAR DE MANERA AMBULATORIA POR LO QUE SE DECIDE DAR ALTE MÉDICO CON TRATAMIENTO RIPE AMBULATORIO, ADemás CON CITA CONTROL CON INFECTOLOGÍA, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SE EXPLICA ESTADO CLÍNICO Y MANEJO A PACIENTE Y FAMILIARES QUIENES REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Fecha: 02/01/2020

- 871121 - RADIOGRAFÍA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)- Cantidad: 1
- 902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 04/01/2020

- 901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS- Cantidad: 3

Fecha: 05/01/2020

- 901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS- Cantidad: 1

Fecha: 06/01/2020

- 906249 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS- Cantidad: 1

Fecha: 07/01/2020

- 901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO- Cantidad: 1
- 903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1
- 903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903866 - TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICO [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
- 903867 - TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 906127 - TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906129 - TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906205 - CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906206 - CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906213 - EPSTEIN-BARR ANTICUERPOS IG G (NUCLEARES EBNA-G) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906216 - EPSTEIN-BARR ANTICUERPOS IG M (NUCLEARES EBNA-M) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906220 - HEPATITIS B ANTICUERPOS CENTRAL IG M [ANTI-CORE HBC-M] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906225 - HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906228 - HERPES I ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906229 - HERPES I ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906230 - HERPES II ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906231 - HERPES II ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 906250 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA PRUEBA CONFIRMATORIA - Cantidad: 1
- 906317 - HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] - Cantidad: 1
- 906915 - PRUEBA NO TREPONÉMICA MANUAL (VDRL) - Cantidad: 1

Fecha: 08/01/2020

- 901007 - MYCOBACTERIUM PRUEBAS DE SENSIBILIDAD- Cantidad: 1
- 902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903604 - CALCIO IÓNICO - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 906039 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONÉMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA - Cantidad: 1
- 906250 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA PRUEBA CONFIRMATORIA - Cantidad: 1
- 906714 - LINFOCITOS T CD4 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

Fecha: 09/01/2020

- 901109 - COLORACIÓN TINTA CHINA Y LECTURA- Cantidad: 1
- 901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS - Cantidad: 1
- 901209 - CULTIVO DE LÍQUIDOS CORPORALES (BILIS LCR PERITONEAL PLEURAL ASCÍTICO SINOVIAL OTROS DIFERENTE A ORINA) - HERIDAS: MICROSCÓPICO, CULTIVO Y AB, GERMENES COMUNES - Cantidad: 1
- 901209 - CULTIVO DE LÍQUIDOS CORPORALES (BILIS LCR PERITONEAL PLEURAL ASCÍTICO SINOVIAL OTROS DIFERENTE A ORINA) - TEJIDOS CORPORALES, MEDICIÓN ENZIMÁTICA - Cantidad: 1
- 901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO - Cantidad: 1
- 901305 - EXÁMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH) - Cantidad: 1
- 903401 - ADENOSIN DEAMINASA [ADA] - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903879 - MAGNESIO EN ORINA PARCIAL - Cantidad: 1
- 906314 - CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTÍGENO - Cantidad: 1
- 906915 - PRUEBA NO TREPONÉMICA MANUAL (VDRL) - Cantidad: 2

Fecha: 10/01/2020

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903604 - CALCIO IONICO - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903850 - LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (LCR EXAMEN FISICO Y CITOQUIMICO CON GLUCOSA PROTEINAS MORFOLOGIA DE ERITROCITOS Y DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS) - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 11/01/2020

-903603 - CALCIO AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 12/01/2020

-903603 - CALCIO AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 13/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 17/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 18/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 19/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 20/01/2020

-903813 - CLORO- Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Fecha: 02/01/2020

-0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 1

-0025 - Intracath # 18 - Cantidad: 1

-H02AH008721 - Hidrocortisona sódico - Cantidad: 2

-HUCDES201 - TAPON VENOSO HEPARINIZADO - Cantidad: 1

-HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1

-HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1

Fecha: 04/01/2020

-0026 - Intracath # 20- Cantidad: 1

-9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR - Cantidad: 1

-HUCDES201 - TAPON VENOSO HEPARINIZADO - Cantidad: 1

-HUCTR15 - CANULA NASAL OXIGENO ADULTO - FUNDACION CARDIOVASCULAR - ITEM(15) - Cantidad: 1

-HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1

-R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG - Cantidad: 1

Fecha: 06/01/2020

-0025 - Intracath # 18- Cantidad: 1

-0026 - Intracath # 20 - Cantidad: 1

-0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 1

-HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 2

-HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 2

Fecha: 07/01/2020

-0006 - Lactato de Ringer (Hartman)- Cantidad: 3

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

-0009 - Agua Destilada - Cantidad: 1
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 13
 -0025 - Intracath # 18 - Cantidad: 1
 -0026 - Intracath # 20 - Cantidad: 1
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 1
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 7
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 2
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 4
 -HUCDES201 - TAPON VENOSO HEPARINIZADO - Cantidad: 1
 -J01CA028721 - Ampicilina sódica + Sulbactam sódico - Cantidad: 12
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 4
 Fecha: 08/01/2020
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 09/01/2020
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003703 - DALTEPARINA SODICA(Heparina de bajo peso molecular) - Cantidad: 1
 -HUCDES166 - JERINGA INSULINA 1 ML - ITEM(169) - Cantidad: 2
 Fecha: 10/01/2020
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 8
 -0018 - Equipo de Venoclisis Macrogoteo - Cantidad: 2
 -0116 - Equipo Bomba de Infusión fressenius - Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 1
 -B01AH004701 - Heparina sódica - Cantidad: 1
 -C01BL010701 - Lidocaina clorhidrato simple 2% X 10 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES127 - GUANTE ESTERIL No. 7 - Cantidad: 2
 -HUCDES166 - JERINGA INSULINA 1 ML - ITEM(169) - Cantidad: 4
 -IM6442 - OPS- PENICILINA G BENZATINICA - Cantidad: 3
 -J01CP007721 - Penicilina G sódica ó Potasica cristalina - Cantidad: 1
 -N03AM001701 - SULFATO DE MAGNESIO - Cantidad: 2
 -SPINOCATH18 - SPINOCATH #18 - Cantidad: 1
 Fecha: 13/01/2020
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -0026 - Intracath # 20 - Cantidad: 2
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 2
 Fecha: 15/01/2020
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 6
 -0116 - Equipo Bomba de Infusión fressenius - Cantidad: 1
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml - Cantidad: 6
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 4
 -J01ET025011 - Trimetoprim + Sulfametoxazol 80/400 mg - Cantidad: 1
 -N03AM001701 - SULFATO DE MAGNESIO - Cantidad: 9
 Fecha: 16/01/2020
 -0027 - Intracath # 22- Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 Fecha: 17/01/2020
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -J01CP005722 - Penicilina G Benzatínica - Cantidad: 1
 -J01ET025011 - Trimetoprim + Sulfametoxazol 80/400 mg - Cantidad: 1
 Fecha: 19/01/2020
 -0027 - Intracath # 22- Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 Fecha: 20/01/2020
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 1
 -0027 - Intracath # 22 - Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 3
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 1
 -J01ET025011 - Trimetoprim + Sulfametoxazol 80/400 mg - Cantidad: 1

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha: 02/01/2020
 Indicaciones:
 OBSERVACION
 TAPON VENOSO
 OXIGENO POR CANULA NASAL A 2LPM
 HIDROCORTISONA AMP 200MG IV EN 100C AHORALENTO
 S/S HEMOGRAMA, BUN, CREATININA,
 S/S RX DE TORAX
 VAL POR MED INTERNA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

CSVYAC

Fecha: 05/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZADO
- TAPON VENOSO
- DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS
- OXIGENO POR CANULA NASAL A 2LT/MIN
- AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 8 HORAS FI: 05/01/20::D0::
- CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 05/01/20::DO::
- S/S VALORACION POR INFECTOLOGIA
- S/S BACILOSCPIA #3
- PTE REALIZACION DE TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO

Fecha: 06/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZADO
- TAPON VENOSO
- DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS
- OXIGENO POR CANULA NASAL A 2LT/MIN
- AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 8 HORAS FI: 05/01/20::D0::
- CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 05/01/20::DO::
- P/: VALORACION POR INFECTOLOGIA
- P/: BACILOSCPIA #3
- PTE REALIZACION DE TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO

Fecha: 06/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZADO
 - TAPON VENOSO
 - DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS
 - OXIGENO POR CANULA NASAL A 2LT/MIN
 - AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 8 HORAS FI: 05/01/20::D1::
 - CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 05/01/20::D1::
 - P/: VALORACION POR INFECTOLOGIA
 - P/: BACILOSCPIA #2
 - S/S: VIH
 - PTE REALIZACION DE TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO
- CIERRE POR MEDICINA INTERNA
SEGUIMIENTO POR INFECTOLOGIA

Fecha: 07/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN INFECTOLOGIA
- TAPON VENOSO
- DIETA NORMAL
- OXIGENO POR CANULA NASAL A 2LT/MIN
- AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 8 HORAS FI: 05/01/20::D1:: SUSPENDER:::
- CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 05/01/20::D1::: SUSPENDER:::
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 :::NUEVO:::
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA::: NUEVO:::
- P/: BACILOSCPIA #2
- PTE REALIZACION DE TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO
- SS/ ELISA DE 4 TA GENERACION PARA VIH, AST, ALT, BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA, BUN, CREATININA, VDRL, HBAgS, ANTICORE IgG e IgMHB, IgMHC, IgG E IgM PARA CMV, HERPES, EPSTEIN BARR Y TOXOPLASMA

Fecha: 08/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN INFECTOLOGIA
- TAPON VENOSO
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D1)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- HEPARINA 2.500 UNIDADES SC CADA 12 HORAS
- S/S GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2
- P/ PARACLÍNICOS

Fecha: 09/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZADO EN INFECTOLOGIA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

- TAPON VENOSO
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 1 HORA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D3)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- HEPARINA 2.500 UNIDADES SC CADA 12 HORAS
- S/S IONOGRAMA CONTROL PARA MAÑANA
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2
- CSV Y AC

Fecha: 09/01/2020

Indicaciones:

- SE INDICA PENICILINA BENZATINICA 2.4 MILLIDES UI IM CADA SEMANA POR 3 DOSIS (09/01 - 16/01 - 23/01)

Fecha: 09/01/2020

Indicaciones:

SE SOLICITA ESPINOCAT # 20 O 18 SEGUN DISPONIBILIDAD # 1, FRASCOS RECOLECTORES DE MUESTRAS # 3, LIDOCAINA SOLUCIÓN 2% SIN EPINEFRINA 2%, GUANTES ESTERILES NUMERO 7.0 # 3, JERINGA DE 10 CC #2, EQUIPO MACROGOTEO #1, GASAS Y APOSITOS PARA LIMPIEZA

Fecha: 10/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZADO EN INFECTOLOGIA
- TAPON VENOSO
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 1 HORA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D4)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- HEPARINA 2.500 UNIDADES SC CADA 12 HORAS::SUSPENDER::
- S/S IONOGRAMA CONTROL PARA MAÑANA
- S/S INTERCONSULTA CON NUTRICIÓN CLÍNICA Y PSICOLOGÍA
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2
- CSV Y AC

Fecha: 11/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 1 HORA
- ION K 15 CC CADA 8 HORAS DURANTE 24 HORAS
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D5)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- S/S IONOGRAMA CONTROL
- S/S INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2 Y #3
- CSV Y AC

Fecha: 11/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 1 HORA
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D5)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- S/S IONOGRAMA CONTROL
- S/S INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2 Y #3
- CSV Y AC

Fecha: 12/01/2020

Indicaciones:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 1 HORA
- ION K 15 CC CADA 8 HORAS DURANTE 24 HORAS
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D5)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, INICIAR LUNES 13/01/20, PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES::NUEVO:
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- S/S IONOGRAMA CONTROL
- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2 Y #3
- CSV Y AC

Fecha: 13/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- 1 AMPOLLA DE SULFATO DE MAGNESIO CADA 12 HORAS, PASAR IV POR BOMBA DE INFUSIÓN EN 1 HORA SUSPENDER MAÑANA
- ION K 15 CC CADA 8 HORAS DURANTE 24 HORAS :::SUSPENDER:::
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D6)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, INICIAR LUNES 13/01/20, PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- S/S IONOGRAMA CONTROL
- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2 Y #3
- S/S TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO
- CSV Y AC

Fecha: 14/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D7)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI(13/01/20 DIA 1) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2 Y #3
- S/S TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO
- CSV Y AC

Fecha: 15/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D8)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20 DIA 1) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCPIA #2 Y #3
- P/ TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO
- CSV Y AC

Fecha: 16/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D8)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20 DIA 1) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA

- PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI IM APLICA HOY Y REPERI EL (24/01/2020 D3) (2DA DOSIS)

- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL

- P/ GENEXPERT

- P/ BACILOCOSPIA #2 Y #3

- P/ TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO

- CSV Y AC

Fecha: 17/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO

- TAPÓN VENOSO

- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D10)

- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA

- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20 DIA 3) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA

- PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI IM APLICA HOY Y REPERI EL (24/01/2020 D3) (2DA DOSIS)

- S/S IONOGRAMA, BUN, CREATININA

- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL

- P/ GENEXPERT

- P/ BACILOCOSPIA #2 Y #3

- P/ TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO

- CSV Y AC

Fecha: 17/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO

- TAPÓN VENOSO

- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D9)

- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA

- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20 DIA 3) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA

- PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI IM APLICA HOY Y REPERI EL (24/01/2020 D3) (2DA DOSIS)

- S/S IONOGRAMA, BUN, CREATININA

- P/ INTERCONSULTA CON TRABAJO SOCIAL

- P/ GENEXPERT

- P/ BACILOCOSPIA #2 Y #3

- P/ TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO

- CSV Y AC

Fecha: 18/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO

- TAPÓN VENOSO

- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS

- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D11)

- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA

- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20 D3) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA

- PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI IM REPETIR EL (24/01/2020 D3) (2DA DOSIS)

- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO, BUN, CREATININA

- P/ GENEXPERT

- P/ BACILOCOSPIA #2 Y #3

- P/ TERAPIA RESPIRATORIA PARA AYUDAR A RECOLECTAR MUESTRA DE ESPUTO

- CSV Y AC

Fecha: 19/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO

- TAPÓN VENOSO

- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS

- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D12)

- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA

- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20 D3) PARA CONTINUAR DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:34:30 p. m.

Admisión: AD568215

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: EDILBERTO PADILLA MELGAREJO

EPICRISIS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI IM EL (24/01/2020 D3) (2DA DOSIS)
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO, BUN, CREATININA
- P/ GENEXPERT
- P/ BACILOSCOPIA #2 Y #3
- CSV Y AC

Fecha: 20/01/2020

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
- TAPÓN VENOSO
- SULFATO DE MAGNESIO 1 AMP CADA 12 HORAS POR BIC PASAR EN 2 HORAS
- TERAPIA RIPE RHZE (150/75/400/275 MG DAR 2 TAB VO CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) FI: 07/01/2020 (D13)
- PIRIDOXINA 100 MG VO CADA DÍA
- TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG VO, TRES VECES POR SEMANA, FI (13/01/20) HOY 4TA DOSIS (LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES)
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DÍA
- PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI IM EL (24/01/2020 D3) (2DA DOSIS)
- S/S IONOGRAMA + MAGNESIO, BUN, CREATININA
- P/ GENEXPERT
- CSV Y AC

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

VER REGISTRO DE HISTORIA CLINICA

Complicaciones:

NINGUNA

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Egreso: 21/01/2020 09:04

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: B24X: ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION

Diagnóstico Relacionado 1: A150: TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO

Diagnóstico Relacionado 2: A539: SIFILIS, NO ESPECIFICADA

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:

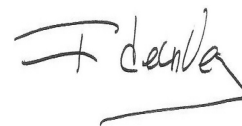
Tratamiento Farmacológico:

ISONIACIDA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL, RIFAMPICINA

Recomendaciones Adicionales:

VINCULARSE A PROGRAMA PARA VIH, VINCULARSE AL PROGRAMA PARA TUBERCULOSIS

Aplica Cuidados de Enfermería: No



FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO
INFECTOLOGIA

CC.73099305 - RM.CC:73099305 - RM:1414